HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Traitement de l'infection à *H. pylori* chez l'adulte

Jeu de diapositives réalisé par le comité des référentiels de la SPILF à partir des recommandations HAS 2017

21 avril 2021

Généralités

- Prévalence de l'infection: En France, la prévalence varie de 15 à 30%, < 20% chez les moins de 30 ans, et environ 50% après l'âge de 50- 60 ans .
- Forte prévalence de la résistance aux antibiotiques en France : clarithromycine 20,9%, lévofloxacine 17,6%, métronidazole 58,6%
- L'infection est asymptomatique dans 85% des cas.
- Les risques associés à la chronicité de l'infection sont: L'ulcère gastro-duodénal, le cancer et le lymphome du MALT (bactérie classée oncogène).

Cancer et *Helicobacter pylori* (*Hp*)

- En France cancer gastrique : 6560 cas en 2018, espérance de survie à 5 ans de 20%
  - ✓ Une infection à Hp est identifiée comme facteur de risque dans 80% des cas.
  - ✓ L'éradication de Hp avant l'atrophie et la métaplasie intestinale prévient l'évolution vers le cancer.
- 2/3 des lymphomes de MALT gastriques sont liés à une infection à Hp.
  - ✓ L'éradication de Hp permet la régression du lymphome dans 60 à 90% des cas

Ulcère gastro-duodenal et *Hp*

- En France : 90 000 cas/an.
- 10% des personnes infectées développeront un ulcère
- 95% des ulcères duodénaux et 70% des ulcères gastriques sont associés à une infection par Hp
- 60 % des ulcères récidivent en l'absence d'éradication de Hp.

Situations justifiant la recherche d'une infection à *H. pylori*

- Ulcère gastrique ou duodénal
- Lymphome gastrique de type MALT
- Patient ayant eu une gastrectomie partielle pour cancer (ou un traitement par endoscopie de lésions cancéreuses gastriques)
- Patient avec lésions prénéoplasiques gastriques (atrophie sévère et/ou métaplasie intestinale, dysplasie)
- Personne ayant un syndrome de prédisposition aux cancers digestifs (HNPCC/Lynch)
- Patient devant subir une chirurgie bariatrique isolant une partie de l'estomac

Situations justifiant la recherche d'une infection à *Hp*

- Dyspepsie chronique avec gastroscopie normale
- Avant prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d'aspirine à faible dose si antécédent d'ulcère
- Traitement continu programmé par IPP de plus de 3 ans
- Personne apparentée au premier degré à un patient ayant eu un cancer de l'estomac
- Anémie ferriprive sans cause retrouvée ou résistante à un traitement oral par fer
- Carence en vitamine B12 sans cause retrouvée
- Purpura thrombopénique immunologique de l'adulte

Diagnostic de l'infection Gastroscopie

Lors de la gastroscopie, la réalisation de biopsies (7 au total) doit être systématique pour:

- L'examen histologique afin de détecter Hp et des lésions prénéoplasiques :
  5 biopsies : 2 dans l'antre, 1 dans l'angle, 2 dans le fundus.

- L'examen bactériologique :
  2 biopsies en milieu de transport spécifique

- PCR (sensibilité à la clarithromycine) et/ou culture avec antibiogramme

Diagnostic de l'infection
Techniques non invasives

- Test respiratoire à l'urée marquée au ^{13}C (non remboursé pour le diagnostic)
- Sérologie
- Recherche d'Ag dans les selles (non remboursé)
- PCR dans les selles couplée à la détection de la résistance à la clarithromycine (non remboursé)

Personnes ou patients sans symptôme digestif :

- < 40-45 ans, apparentés à un patient ayant eu un cancer gastrique ;
- ou avec antécédent d'ulcère sans preuve d'éradication de *H. pylori* (y compris avant prise d'AINS ou d'aspirine à faible dose) ;
- ou avec purpura thrombopénique immunologique.

Patients avec symptômes orientant vers une pathologie digestive haute notamment :

- syndrome ulcéreux ;
- dyspepsie chez un patient > 40-45 ans et/ou en cas de symptômes d'alarme (dont dysphagie, amaigrissement, anémie) ;
- anémie ferriprive ou carence en vitamine B12 sans cause trouvée.

Patients avec facteurs de risque de cancer gastrique :

- personnes > 40-45 ans, apparentées à un patient ayant eu un cancer gastrique ;
- autres facteurs de risque.

Lymphome gastrique du MALT

Intervention bariatrique prévue

Sérologie *H. pylori*

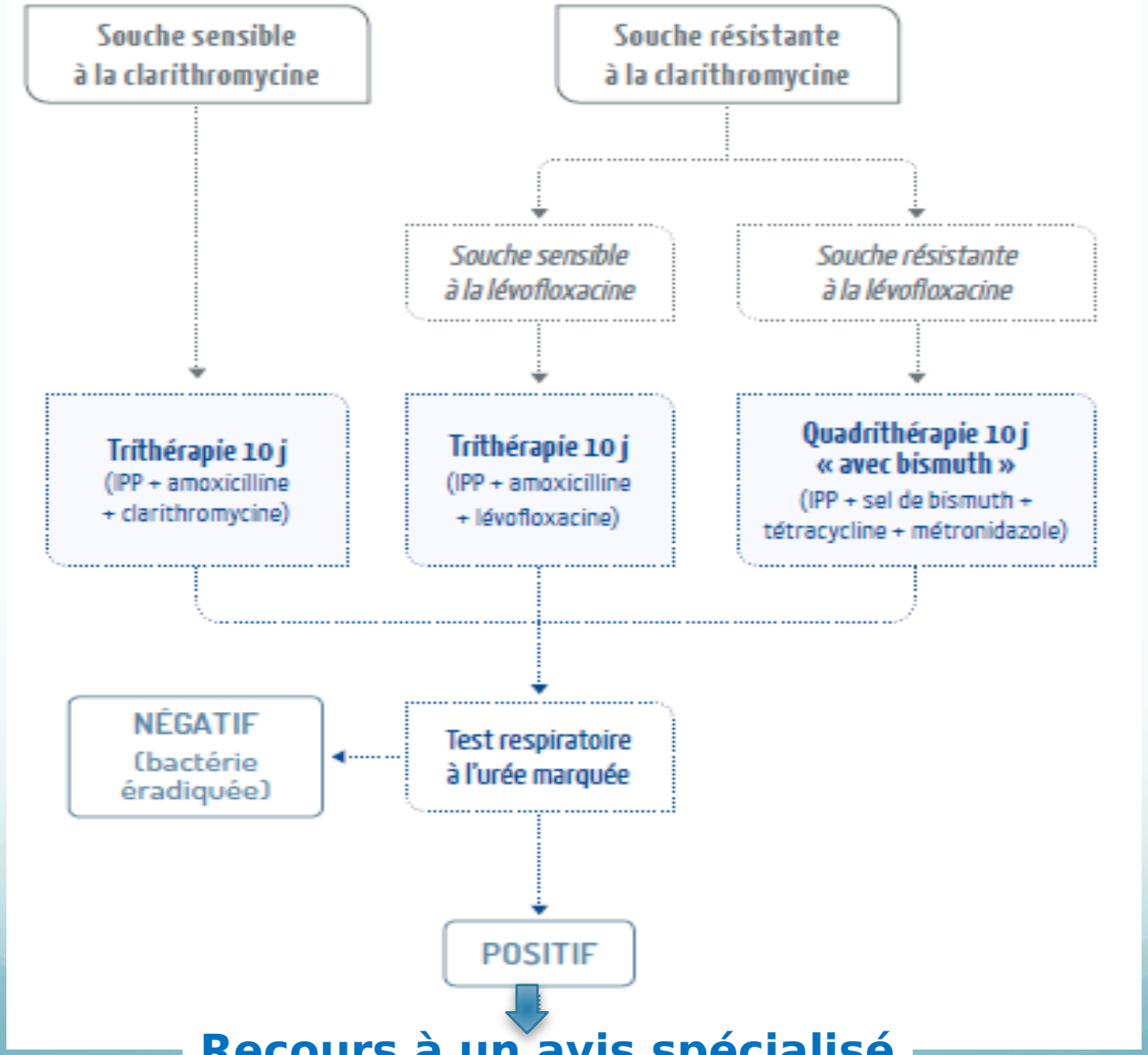
NÉGATIF
Pas d'infection active

POSITIF
ou douteux

Gastroscopie et/ou étude de la sensibilité aux antibiotiques non réalisées

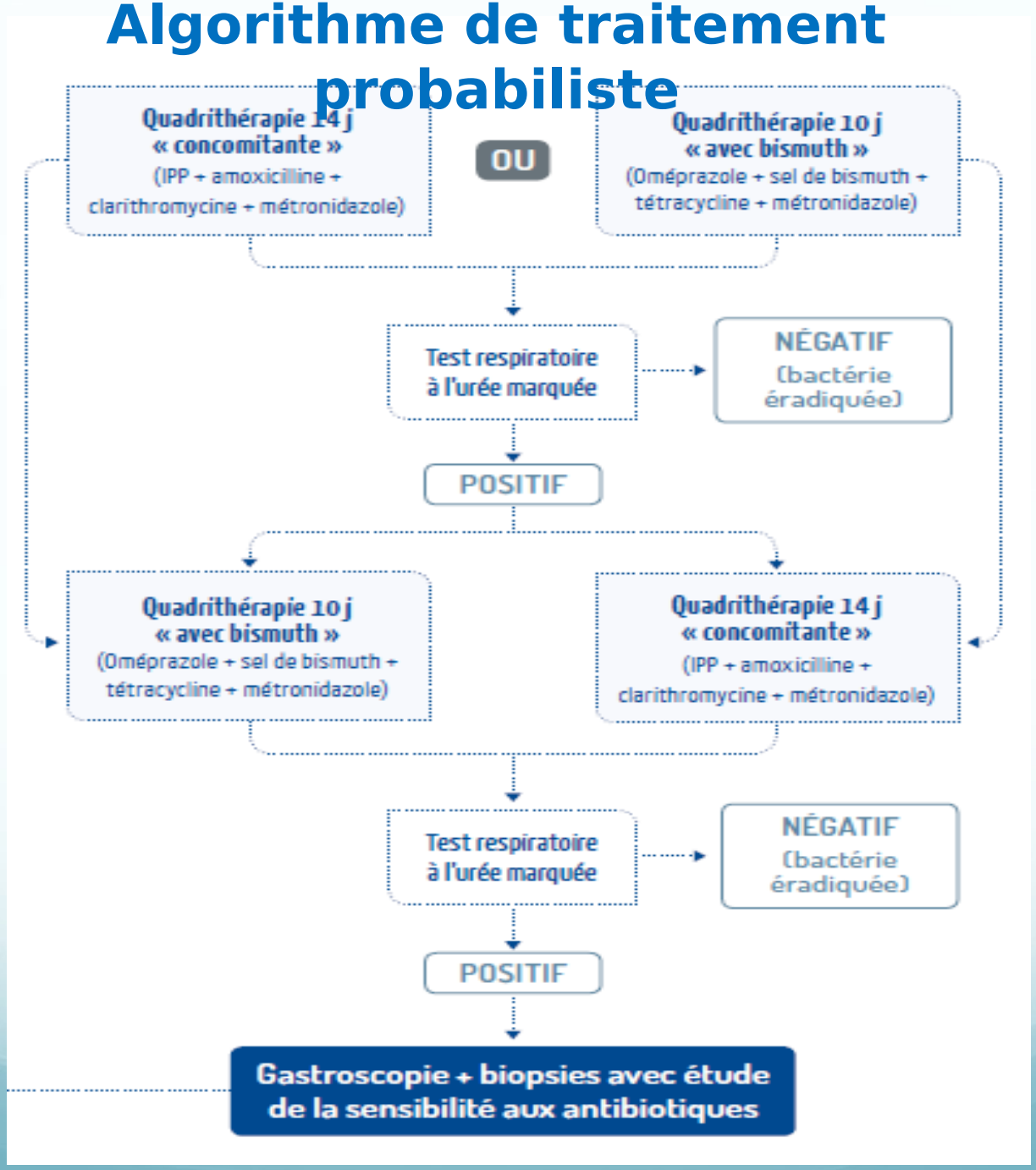
Gastroscopie avec biopsies [analyse anatomopathologique + bactériologique (si disponible)]

Algorithme de traitement en fonction de l'antibiogramme: Traitement guidé

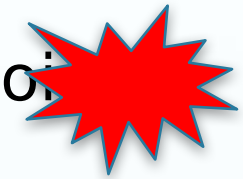


Recours à un avis spécialisé

Algorithme de traitement probabiliste



Posologie

- IPP: 1 dose matin et soir
- Amoxicilline: 1g matin et soir  Cf diapositive suivante
- Clarithromycine : 500 mg matin et soir
- Lévofloxacine : 500 mg matin (M et S pour le GEFH)
- Métronidazole : 500 mg matin et soir
- Pylera® : 3 gélules 4 fois/jour associé à oméprazole 20mgx2

Commentaire de la SPILF

Posologie de l'amoxicilline proposée par la SPILF

50 mg/kg/j en 3 à 4 prises par jour

Rationnel:

- Les posologies d'amoxicilline ont été définit historiquement en deux prises quotidiennes, dans un objectif de simplification (prise simultanée avec l'IPP et la clarithromycine).

- L'émergence des résistances aux macrolides et aux FQ justifie d'optimiser la prescription de l'amoxicilline, qui reste la seule molécule systématiquement active.

- Les études PK/PD de l'amoxicilline par voie orale montrent la nécessité de fractionner les doses et d'adapter la posologie au poids du patient.

Zhu YJ et al. Therap Adv Gastroenterol ; 13: 1756284820937115. doi: 10.1177/1756284820937115
Gao CP et al . Helicobacter 2020 : e12692. doi: 10.1111/hel.12692

Contrôle de l’éradication

Un contrôle de l’éradication doit être réalisé systématiquement après chaque ligne de traitement.

Le test respiratoire à l’urée marquée est une méthode performante pour contrôler l’efficacité de l’éradication à condition d’être réalisée 4 à 6 semaines après la fin du traitement.

La recherche d’antigène fécal est une alternative au test respiratoire mais ce test n’est pas remboursé.